

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: PSWQ

1. Identificación del Instrumento

Título original	The Penn State Worry Questionnaire (PSWQ)
Título español	Inventario de Preocupación de Pensilvania (PSWQ)
Sigla	PSWQ
Autores originales	Meyer, Miller, Metzger y Borkovec
Año original	1990
Adaptador español	Nuevo, Montorio y Ruiz
Año adaptación	2002
Formato	Cuestionario autoadministrado de 16 ítems

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

El PSWQ fue diseñado para evaluar de forma específica el constructo de preocupación patológica de tipo rasgo, que es la característica definitoria del Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG). El instrumento evalúa la generalidad, exceso e incontrolabilidad de las preocupaciones, diferenciándolas de los temores normales y transitorios comunes a la vida cotidiana.

3. Características Generales

Objetivo	Medir la tendencia general a preocuparse de manera excesiva e incontrolable.
Población	Adolescentes, adultos y adultos mayores.
Administración	Autoadministrado (aprox. 3-5 minutos).
Tiempo	Estimado entre 3 y 5 minutos.
Corrección	Suma de los 16 ítems (rango global: 0-64 o 16-80 según escala). En esta versión adaptada se puntúa de 0 a 4 (rango 0-64).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión / Factor	Ítems	Descripción
Preocupación patológica general	Ítems 1 al 16 (Se preocupa si no tiene tiempo, preocupaciones le agobian, incontrolabilidad, preocupación de por vida)	Medida unidimensional de la incontrolabilidad, intensidad y carácter generalizado de la preocupación.

5. Sistema de Puntuación

En esta adaptación específica de Nuevo et al. (2002) para población de adultos mayores, los 16 ítems se responden en una escala del 0 al 4 (donde 0 = Nada y 4 = Mucho). Todos los ítems están redactados en sentido positivo, por lo que la puntuación total se calcula mediante la suma directa (rango: 0-64). Esto evita la inversión de puntuación que sí posee la escala original en inglés en 5 de sus ítems (1, 3, 8, 10, 11) que solían provocar errores de interpretación.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Las puntuaciones se interpretan de forma continua: a mayor puntuación, mayor severidad de la preocupación patológica. Un punto de corte de 56 o más en la escala original (y su equivalente en percentiles en esta versión adaptada) se asocia con un diagnóstico probable de Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y amerita evaluación diagnóstica clínica formal.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

El PSWQ demuestra excelentes cualidades psicométricas. Su consistencia interna original y en adaptaciones clínicas reporta valores de Alfa de Cronbach consistentes entre 0.88 y 0.95. En la adaptación de Nuevo et al. (2002), el Alfa de Cronbach alcanzó 0.95, demostrando que la simplificación de los ítems inversos mejoró sustancialmente la fiabilidad métrica.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

El estudio de aplicabilidad de Nuevo, Montorio y Ruiz (2002) demostró que la versión sin ítems inversos eliminó el sesgo de comprensión en personas de edad avanzada y mantuvo la misma estructura factorial unidimensional que el instrumento original de Meyer et al.

9. Aplicaciones Prácticas

Cribado de Trastorno de Ansiedad Generalizada, evaluación diagnóstica de trastornos de ansiedad y monitoreo de la efectividad de la terapia cognitivo-conductual.

10. Fortalezas del Instrumento

- Versión en español depurada sin ítems inversos, eliminando problemas cognitivos de comprensión.
- Consistencia interna sumamente alta.
- Diferencia de manera clara la preocupación patológica (incontrolable) de la normal.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- Instrumento de autoinforme (propenso a sesgos de deseabilidad social).
- No evalúa el contenido temático específico de las preocupaciones, solo su forma e incontrolabilidad.

12. Consideraciones Éticas y Legales

Debe aplicarse respetando la voluntariedad y confidencialidad de la información. El diagnóstico definitivo de TAG debe basarse en criterios diagnósticos estructurados del DSM-5.

13. Síntesis Técnica General

El PSWQ adaptado por Nuevo y colaboradores es una herramienta de cribado clínico óptima y altamente fiable para medir la incontrolabilidad de las preocupaciones sin los inconvenientes de los ítems en sentido negativo.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L., & Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. *Behaviour Research and Therapy*, 28(6), 487-495.
- Nuevo, R., Montorio, I., & Ruiz, M. Á. (2002). Aplicabilidad del Inventario de Preocupación de Pensilvania (PSWQ) a población de edad avanzada. *Ansiedad y Estrés*, 8(2-3), 157-172.